

БЕКИТЕМ

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо жана социалдык
өнүктүрүү министрлигинин алдындагы
Дары каражаттары жана медициналык
буюмдар департаментинин
директорунун орун басары

Мамбеталиева Ч. М.

«11»

ноябрь

2021-ж.

**ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА
НУСКАМА**

КРЕДАВЕЙТ

Соодадагы аталышы: Кредавейт

Эл аралык патенттелбеген аталышы: Клобетазол

Дарынын түрү

Сырттан колдонуу үчүн мазь

Курамы

Активдүү зат: 0,05% в/в ВР клобетазол пропионаты.

Көмөкчү заттар: полиэтиленгликоль (ПЭГ 400), полиэтиленгликоль (ПЭГ 4000), метилпарабен, пропилпарабен, пропиленгликоль.

Сүрөттөмөсү

Алюминий тубага толтурулган, кремдүү жарым катуу масса

Фармакодарылык тобу: Тери ооруларын дарылоо үчүн препараттар. Дерматологияда колдонулуучу кортикостероиддер. Кортикостероиддер. Жогору активдүү кортикостероиддер (IV тобу). Клобетазол.

АТХ коду: D07AD01.

Фармакологиялык таасири

Фармакодинамикасы

Таасир берүү механизми

Сырттан колдонуу үчүн кортикостероиддердин сезгенүүгө каршы таасири көпчүлүк факторлорго шартталган, анын натыйжасында аллергиялык реакциялардын өтүшкөн фазаларын басандатуу, анын ичинде мастоциттер тыгыздыгын төмөндөтүү, хемотаксистин жана эозинофилдердин активдешүүсүнүн азайышы, лимфоциттер, моноциттер, мастоциттер жана эозинофилдер менен цитокиндерди иштеп чыгуунун азайышы жана арахидин кислотасынын зат алмашуусун басандатуу жүрөт.

Фармакодинамикалык натыйжасы

Сырттан колдонуу үчүн кортикостероиддер сезгенүүгө каршы, кычышууга каршы жана кан тамыр кеңейтүүчү таасирлерди берет.

Препарат вазоконстрикцияны жана коллаген синтезинин төмөндөшүн пайда кылат. Сыйпаган жерде шишимикти, кызарууну жана кычышууну жок кылат.

Фармакокинетикасы

Клобетазол пропионаттын орточо C_{max} 0,63 нг/мл түзөт жана биринчи аппликациядан кийин 13 сааттан кийин плазмада жана 0,05% мазь түрүндө 30 г клобетазол пропионатты дени-сак териге кайталап сыйпагандан 8 сааттан кийин жетет. Мазь түрүндөгү клобетазол пропионаттын экинчи дозасын (30 г) аппликациялоодон 10 сааттан кийин анын плазмадагы орточо C_{max} мазды сыйпагандан кийинкиден бир аз жогору болот. 25 г 0,05% клобетазол пропионат мазын бир жолу сыйпагандан 3 сааттан кийин псориазы жана экземасы бар бейтаптарда плазмадагы препараттын орточо C_{max} ылайыгына жараша 2,3 нг/мл жана 4,6 нг/мл түзөт.

Негизинен боор аркылуу, калган бөлүгү – бөйрөк аркылуу зат алмашат. Заара аркылуу бөлүнүп чыгат.

Колдонууга көрсөтмө

- псориаз (кеңири тараган жайылган псориаздан сырткары);
- экзема (рефрактердик формалары);
- кызыл жалпак чакалай;
- дискоиддик канчоо;
- азыраак активдүү глюкокортикоиддер менен дарылоого туруктуу башка тери оорулары;
- сырттан колдонуу үчүн азыраак активдүү ГКС менен дарылоого туруктуу тери оорулары.

Кредавейт мазы кургактык, гиперкератоз, калыңдануу менен коштолгон тери жабыркоолорунда колдонууга сунушталат, себеби препараттын маздык курамы териде нымдын сакталышына түрткү берет, ал эми крем суулануу жана айкын сезгенүү менен коштолгон процесстерде колдонууга сунушталат.

Каршы көрсөтмө

- препараттын курам бөлүктөрүнө жогору сезгичтик;
- кызгылт безеткилер;
- одоно безеткилер;

- теринин рагы;
- Гайда түйүндүү кычыткысы;
- периоралдуу дерматит;
- перианалдык жана жыныс мүчөлөрүнүн кычышуусу;
- теринин бактериялык, вирустук жана мите козу карындык оорулары (жөнөкөй учук, суу чечек, теринин кургак учугу, актиномикоз);
- кеңири тараган жайылган жана ириңдүү исиркектүү псориаз;
- 1 жашка чейинки курак;
- бала эмизүү мезгили.

Колдонуу жолу жана дозасы

Мазь жабыркаган териге жука катмарда натыйжа алганга чейин күнүгө бир-эки жолу сыйпалат. Дарылоону 4 жумадан ашык аны улантуу зарылдыгын баалабастан жүргүзүүгө болбойт. Тери ооруларынын күчөшүн дарылоо үчүн Кредавейт препараты менен кыска курстарды кайталап жүргүзүүгө болот. Эгерде глюкокортикостероиддер менен дарылоону улантуу зарыл болсо, азыраак активдүү препараттарды колдонуу керек.

Өзгөчө туруктуу учурларда, өзгөчө гиперкератоз болушунда, Кредавейт мазынын сезгенүүгө каршы таасири препаратты колдонгон жакка түнкүсүн полиэтилен жукасынан таңгыч коюунун жардамы менен күчөтүлүшү мүмкүн, бул адатта оң таасир менен коштолот. Андан ары жеткен таасирин жабык таңгыч колдонбостон колдоого болот.

Кыйыр таасири

Жагымсыз көрүнүштөрү төмөндө системалык-органдык класска жана кездешүү жыштыгына жараша саналып берилген. Кездешүү жыштыгы төмөнкүдөй негизде аныкталат: абдан тез-тез (≥ 10), тез-тез ($\geq 1/100$ жана $< 1/10$), көп эмес ($\geq 1/1000$ жана $< 1/100$), сейрек ($\geq 1/10000$ жана $< 1/1000$) жана абдан сейрек ($< 1/10000$), анын ичинде айрым учурлар.

Маркетингден кийинки колдонуунун маалыматтары

Инфекциялык жана мите куртук оорулар

Абдан сейрек

- оппортунисттик инфекциялар

Иммундук система тарабынан бузулуулар

Абдан сейрек

- өтө сезгичтик
- жайылган бөртмө

Эндокриндик система тарабынан бузулуулар

Абдан сейрек

- гипоталамдык-гипофизардык-бөйрөк үстүндөгү бездер системасынын басылышы – Кушингоид же гиперкортицизм белгилери: (мисалы, ай сымал бет, борбордук тип боюнча семирүү), салмак кошуунун кечигиши / балдардын өсүшүнүн кармалышы, остеопороз,

глаукома, гипергликемия/глюкозурия, катаракта, гипертония, дене салмагынын жогорулашы /семирүү, эндогендик кортизол деңгээлдеринин төмөндөшү, жаргак баш, чачтардын морттугу.

Тери жана тери алдындагы ткандар тарабынан бузулуулар

Тез-тез

- кычышуу, жергиликтүү ачышуу сезими / теринин ооруксунушу

Көп эмес

- теринин жергиликтүү атрофиясы*
- чоюлуулар*
- кыл тамырлардын кеңейиши*

Абдан сейрек

- теринин жукарышы* (узакка жана ыкчам дарылоодо)
- теринин бырышы*, теринин кургашы *
- пигментациянын өзгөрүшү*, гипертрихоз
- оорунун симптомдорунун күчөшү
- дерматит
- ириндүү исиркектүү псориаз
- эритема, бөртмө, кычышуу, бөрү жатыш, аллергиялык контакттуу дерматит/дерматит
- безетки (безетки бөртмөсү)

Өтө сезгичтик белгилери пайда болушунда препаратты колдонууну токтотуу керек.

Жогору активдүү ГКСтер менен узакка жана ыкчам дарылоо чоюлуу жана теринин жукарышы сыяктуу атрофиялык өзгөрүүлөрдү пайда кылышы мүмкүн. Сейрек учурларда ГКС менен псориазды дарылоо (же аны токтотуу) оорунун ириндүү исиркектүү түрүн күчөтүшү мүмкүн. Жогору активдүү ГКС менен узакка жана ыкчам дарылоо үстүнкү кан тамырлардын кеңейишине, өзгөчө герметикалык таңгычты колдонууда же препаратты теринин бүктөмдөрүнө сүртүүдө алып келиши мүмкүн.

Жалпы мүнөздөгү оорлошуулар жана сыйпаган жердеги реакциялар

Абдан сейрек

- дүүлүгүү жана/же сыйпаган жердин ооруксунушу

*Тери көрүнүштөрү гипоталамдык-гипофизардык-бөйрөк үстүндөгү бездер системасынын басылышынын жергиликтүү жана/же системалуу таасирлерине карата экинчи орунда.

Препараттын жагымсыз кыйыр реакциялары тууралуу маалыматтарды берүү абдан маанилүү, бул дары каражатынын пайда/зиянынын катышын тынымсыз көзөмөлдөөнү ишке ашырууга мүмкүндүк берет. Медициналык кызматкерлерге нускаманын аягында көрсөтүлгөн байланыштар аркылуу, ошондой эле маалыматты чогултуу улуттук системасы аркылуу бардык болжолдонгон жагымсыз реакциялары тууралуу маалыматты берүү керек.

Ашыкча доза

Симптомдору

Клобетазол жетиштүү өлчөмдө сиңишинде системалуу таасирлерди пайда кылышы мүмкүн.

Курч дозасынан ашыруунун пайда болушу мүмкүн эмес, бирок өнөкөт дозасынан ашыруу учурларында же туура эмес колдонууда гиперкортицизм белгилери пайда болушу мүмкүн, бул дарыны токтотууну талап кылат.

Дарылоо

Дозасынан ашыруу учурларында, клобетазол глюкокортикостероиддик жетишсиздиктин өрчүү коркунучуна байланыштуу колдонуу жыштыгын азайтып же азыраак таасир берүү күчү бар кортикостероидге алмаштыруу жолу менен акырындап токтотулушу керек.

Дарылык өз ара таасири

СҮРЗА4 (мисалы, ритонавир жана итраконазол) басаңдатышы мүмкүн болгон дарыларды бирге колдонуу кортикостероиддердин зат алмашуусун басары белгилүү, бул системалуу таасиринин көбөйүшүнө алып келет. Өз ара таасири клиникалык маанилүү болуп эсептелген баскычы дозасына жана кортикостероиддерди колдонуу ыкмасына жана СҮРЗА4 басаңдаткычынын активдүүлүгүнө көз каранды.

Өзгөчө көрсөтмөлөр

Клобетазолду оору таржымалында башка кортикостероиддерге же бардык препараттын курамындагы көмөкчү заттардын кайсы бирине жергиликтүү өтө сезгичтиги бар бейтаптарга этияттык менен колдонуу керек. Өтө сезгичтиктин жергиликтүү реакциялары оорунун болуп жаткан симптомдору менен окшош болушу мүмкүн.

Кредавейт маздын курамында пропиленгликоль бар, ал терини дүүлүктүрүшү мүмкүн.

Кээ бир адамдарда жергиликтүү стероиддердин жогору системалуу абсорбциясынын натыйжасында гиперкортицизм көрүнүштөрү (Кушинг синдрому) жана глюкокортикостероиддик жетишсиздикке алып келүүчү гипоталамдык-гипофизардык-бөйрөк үстүндөгү бездер системасынын калыбына келме басылышы пайда болушу мүмкүн. Жогоруда көрсөтүлгөн көрүнүштөр пайда болгон учурларда аны сыйпоо жыштыгын азайтып же аны азыраак активдүү кортикостероид менен алмаштырып препаратты акырындык менен токтотуу керек. Дарылоону капыстан дароо токтотуу глюкокортикостероиддик жетишсиздиктин өрчүшүнө алып келиши мүмкүн.

Системалуу таасирлеринин күчөө коркунуч факторлоруна төмөнкүлөр кирет:

- активдүүлүк жана жергиликтүү стероид дарылык түрү
- колдонуунун узактыгы
- препаратты теринин кеңири бөлүгүнө сыйпоо
- теринин жабык бөлүктөрүнө колдонуу (б.а. интертригиноздук зоналарда же жабык таңгычтардын алдында)
- теринин мүйүздүү катмарынын абдан сууланышы
- бет сыяктуу териси жука жерлерге колдонуу
- жабыркаган териге же тери тоскоолдугунун бүтүндүгүнүн бузулушу менен коштолушу мүмкүн болгон башка абалдарда сыйпоо
- чоң адамдарга салыштырмалуу, балдарда сырттан колдонуу үчүн кортикостероиддердин абсорбциясынын жогору пайызы белгилениши мүмкүн, ушуга байланыштуу бейтаптардын бул категориясы системалуу кыйыр таасирлеринин өрчүү коркунучуна көбүрөөк тушугат. Бул

балдардын тери тоскоолдугу жетиле электигине жана чоң адамдарга салыштырмалуу дене үстүнүн аянтынын дене салмагына болгон катышынын мааниси чоңдугуна шартталган.

Жабык таңгычтарды колдонууда инфекциянын өрчүү коркунучу

Тери бүктөмдөрүндө, ошондой эле жабык таңгычты коюуда жылуу нымдуу түзүлгөн шарт бактериялык инфекциянын пайда болушуна түрткү берет. Ошондуктан жабык таңгычты колдонууда жаңы таңгычты коёрдун алдында терини дыкат тазалоо керек.

Псориазда колдонуу

Псориазды дарылоо үчүн сырттан колдонуу үчүн кортикостероиддерди этияттык менен колдонуу керек, себеби кээ бир учурларда оорунун симптомдорунун калыбына келиши, препаратка туруктуулуктун өрчүшү, псориаздын жайылган ириңдүү исиректүү түрүнүн коркунучу же теринин тоскоолдук функциясынын бузулушунан улам жалпы токсиндүүлүктүн болушу тууралуу маалымдалган. Псориазды дарылоодо бейтапты дыкат көзөмөлдөө маанилүү.

Кошумча инфекция

Экинчи инфекцияга кошулууда тиешелүү бактерияга каршы дарылоо жүргүзүү керек. Инфекциянын жайылышынын бардык белгилеринде сырттан колдонуу үчүн кортикостероиддерди колдонууну токтотуу жана бактерияга каршы препараттар менен тиешелүү дарылоо жүргүзүү зарыл. Герметикалык таңгычтарды колдонордун алдында терини тазалоо зарыл, себеби таңгычтын алдында пайда болгон жылуулук жана нымдуулук бактериялык инфекциянын пайда болушуна түрткү берет.

Шыйрактардын өнөкөт жаралары

Сырттан колдонуу үчүн кортикостероиддер кээде шыйрактардын өнөкөт жараларынын тегерегинде пайда болгон дерматитти дарылоо үчүн колдонулат. Бирок мындай колдонуу жергиликтүү өтө сезгичтик реакциясынын пайда болушунун жогору жыштыгы жана жергиликтүү реакциялардын жогору өрчүү коркунучу менен коштолушу мүмкүн.

Бетке сыйпоо

Беттин терисине сыйпоо ылайыксыз, себеби бул жак атрофиялык өзгөрүүлөрдүн өрчүшүнө көбүрөөк тушугат.

Беттин терисине сыйпаган учурларда дарылоону 5 күн менен чектөө керек.

Көз капкактарына сыйпоо

Препаратты көз капкактарына сыйпоо ылайыксыз болуп эсептелет. Көз капкактарына сыйпоодо препарат көзгө түшүп кетпеши үчүн көзөмөлдөө зарыл, себеби препараттын кайталанган таасири катаракта жана глаукоманы пайда кылышы мүмкүн. Препарат көзгө түшүп кетсе, көп өлчөмдөгү суу менен жууп салуу зарыл.

Фертилдүүлүк

Сырттан колдонуу үчүн кортикостероиддердин адамдардын репродуктивдик функциясына таасири тууралуу маалыматтар жок.

Кош бойлуулук

Кош бойлуу аялдарга клобетазолду колдонуу тууралуу маалыматтар чектелген.

Кош бойлуу жаныбарларга кортикостероиддерди жергиликтүү колдонуу түйүлдүктүн өрчүшүнүн аномалияларын, анын ичинде таңдай жаракасын (жырык таңдай), жатын ичиндеги түйүлдүктүн өрчүшү кармалышы мүмкүн.

Бул натыйжалардын мааниси адамдар үчүн аныкталган эмес. Клобетазолду кош бойлуу мезгилде эне үчүн пайдасы түйүлдүк үчүн болгон коркунучтан жогору учурларда гана колдонуу керек. Болушунча кыска мезгил ичинде эң төмөн өлчөмүн колдонуу керек.

Бала эмизүү мезгили

Бала эмизүү мезгилинде сырттан колдонуу үчүн кортикостероиддерди колдонуунун коопсуздугу аныкталган эмес.

Кортикостероиддерди жергиликтүү колдонуу эне сүтү менен билинерлик өлчөмдө бөлүнүп чыгышы үчүн жетиштүү системалуу абсорбцияга алып келери белгисиз. Клобетазолду бала эмизүү мезгилинде эне үчүн келтирилген пайда ымыркай үчүн болгон коркунучтан жогору учурларда гана колдонуу керек.

Эгерде клобетазол бала эмизүү мезгилинде колдонулса, аны ымыркай капыстан жутуп алышынан алыс болуу үчүн эмчек тарапка сыйпалбашы керек.

Автоунаа айдоо жана механизмдерди башкаруу жөндөмдүүлүгүнө таасири

Кредавейт мазы автоунаа айдоо жана башкаруу жөндөмдүүлүгүнө таасир тийгизиши мүмкүн эмес.

Чыгаруу формасы

Алюминий тубада сырттан колдонуу үчүн 30 г мазь.

Бир туба колдонуу боюнча нускамасы менен бирге картон кутуда.

Сактоо шарты

Кургак, жарыктан корголгон жерде, 25°C дан жогору эмес аба табында сактоо керек.

Балдар жетпеген жерде сактоо керек.

Жарактуулук мөөнөтү

2 жыл. Жарактуулук мөөнөтү бүткөндөн кийин колдонууга болбойт.

Берүү шарты

Рецепт боюнча

Соода маркасынын жана каттоо күбөлүгүнүн ээси

Belinda Laboratories LLP

Astra House, Arklow Road,

London, England SE14 6EB, UK (Улуу Британия)

Өндүрүүчү

Lark Laboratories (I) Ltd.

SP-1192E, Phase-IV, RIICO Industrial Area,

Bhiwadi, Distt. Alwar (Rajasthan), India (Индия)

**Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүмдүн (товардын) сапаты боюнча
керектөөчүлөрдөн арыз-доолорду кабыл алуучу уюмдун дареги**

**«Аман Pharm» ЖЧК (Аман Фарм), Кыргызстан Республикасы, Бишкек шаары,
Шооруков көч. 36.**

Тел: (0312) 560466, E-mail: aman.pharm12@gmail.com